

Современные методы лечения инфравезикальной обструкции

Мусабек Е.Б.

АО «Научный центр урологии им. Б.У.Джарбусынова»

В настоящее время благодаря совершенствованию эндоскопической техники возможности трансуретральной хирургии значительно расширились. Успешное применение в хирургии сосудистых стенозов спиральных стентов позволило Fabian в 1980 г. предложить первый уретральный стент, названный им «парциальный катетер», или «Urologic spiral», выполненный из нержавеющей стали. Fabian использовал свой стент в простатическом отделе уретры для обеспечения нормального мочеиспускания у больных с заболеваниями предстательной железы.

В настоящее время используются временные и постоянные уретральные стенты. Последние изготавливаются из биостабильных материалов (металлов, сложных сплавов) и имплантируются пациенту пожизненно. Постоянные стенты могут фиксироваться в мочеиспускательном канале благодаря особому дизайну либо иметь саморасширяющуюся конструкцию, в том числе и благодаря использованию сплавов с «памятью формы». В течение 6-18 месяцев после установки такие устройства полностью покрываются уротелием, что позволяет избежать их инкрустации мочевыми солями. Имплантация постоянных металлических стентов является мерой паллиативного характера и применяется, в частности, у больных раком предстательной железы с 1988 года.

Показания к установке уретральных стент-катетеров:

- Гиперплазия и рак простаты, когда адекватное мочеиспускание невозможно восстановить консервативным путем, а оперативное лечение невозможно или должно быть отсрочено;
- Стриктура, рубцовая деформация задней уретры, когда необходима длительная иммобилизация уретры;
- Пациент отказывается от оперативного лечения;
- у больных с психическими расстройствами, когда оперативное лечение не показано или должно быть отсрочено.

Противопоказания к установке стентов: острые воспалительные заболевания мочеполовой системы, хроническая мочевого инфекция, нарушение свертывающей системы крови, новообразование уретры и мочевого пузыря, сморщенный мочевого пузырь, гиперрефлекторный и нестабильный мочевого пузырь, камень мочевого пузыря, свищ уретры.

Возможные осложнения: недержание мочи, гиперпластическая реакция уротелия, миграция, инкрустация, болевой синдром.

Временные уретральные стенты представляют собой целый ряд различных по конструкции устройств, изготовленных из биостабильных или биорастворимых материалов. Такие эндопротезы имплантируются в мочеиспускательный канал на определенные сроки, необходимые для получения клинического эффекта от основного лечения. В настоящее время предложено около десяти типов временных уретральных стентов, изготовленных из металлов и различных полимерных материалов с высокой биосовместимостью. Новые генерации биорастворимых стентов способны к увеличению диаметра в месте имплантации более чем на 40%, благодаря чему достигается

надежная фиксация стента и расширяется просвет уретры. Важнейшим свойством биодеградирующих спиральных стентов является улучшенная биосовместимость или биоинертность.

Временные уретральные стенты применяются и для поддержания просвета простатического отдела уретры при использовании различных не оперативных методов лечения ДГПЖ. Серьезной проблемой является послеоперационная задержка мочи, вызванная отеком простаты. В связи с этим опорожнение мочевого пузыря после процедуры обычно производится уретральным или эпицистостомическим катетером, причем нередко на длительное время. Одним из перспективных способов, обеспечивающих пациенту возможность самостоятельного и адекватного опорожнения мочевого пузыря после проведения малоинвазивных вмешательств, является использование временных стентов. Представленные в литературе опыты имплантации временных стентов показывают, что их применение при задержке мочеиспускания в большинстве случаев позволяет избежать надлобкового дренирования и инфекционных осложнений, связанных с использованием уретрального катетера.

Идея использования временного стента при стриктурах была впервые реализована D. Yachia в 1989. Имплантация эндопротеза после эндоскопического рассечения стриктуры выполняется в надежде на формирование просвета уретры в условиях его поддержания эндопротезом. Кроме того, саморасширяющиеся модели стентов после установки, по мнению ряда авторов, приводят к расхождению краев уретротомических разрезов и тем самым препятствуют рецидиву стриктуры. Новые перспективы в предупреждении рецидивов могут открываться в связи с тем обстоятельством, что использование стента позволяет избежать инфекции, в том числе и госпитальными штаммами, в послеоперационном периоде.

По данным O. Yachia, из 172 пациентов, подвергнутых внутренней оптической уретротомии с имплантацией временного «UroCoil-S» стента из нитинола, лишь у 17% больных ко 2-ому году после удаления стента отмечено образование повторных стриктур в месте операции.

Таким образом, имплантация уретральных стентов является инновационным направлением лечения больных с инфравезикальной обструкцией. Опыт применения уретральных стентов демонстрирует их высокую эффективность при комбинированном эндоскопическом и малоинвазивном лечении заболеваний предстательной железы и уретры.

Имплантация стента обеспечивает больным возможность самостоятельного мочеиспускания и позволяет избежать использования эпицистостомического или уретрального катетера. Избавление пациентов от дренажей является мерой профилактики мочевого инфекции и позволяет значительно уменьшить число осложнений. Применение стентов с паллиативной целью у иноперабельных больных зачастую является единственным приемлемым способом их медицинской и социальной реабилитации.

Литература

1. Лопаткин Н.А., Мартов А.Г. Перспективы современной рентген-эндоскопической урологии // Матер. IX-Всероссийского съезда урологов. - М., 1997. - С. 111-130.
2. Портной А.С. Хирургическое лечение аденомы и рака предстательной железы. - Ленинград: Медицина, 1989. - 256 с.
3. Глобычко П.В., Спиринов В.А., Попков В.М., Спиринов П.В., Назаров М.И. Некоторые причины возникновения воспалительных осложнений в эндоскопической хирургии простаты и мочевого пузыря. Актуальные вопросы хирургии: Материалы науч.-практ. конф. Саратов 2003. С. 189-190.
4. Мухин С.В., Пирузян А.Л. История развития эндоскопической хирургии. Эндоскопическая хирургия и дистанционная литотрипсия. Сборник научных трудов. Москва 1992. С.4-9.
5. Стрельников А.И. Диагностика различных нарушений уродинамики при инфравезикальной обструкции // Иваново-1998 г.
6. Пабильтонес К., Таскано Б. Уродинамика нижних мочевых путей у больных аденомой и раком простаты // М-1998 г.
7. Мартов А.Г., Лопаткин Н.А. Практическое руководство по трансуретральной эндоскопической электрохирургии доброкачественной гиперплазии предстательной железы. - М.: Триада Х. - 1999.
8. Алчинбаев М.К., Малих М.А. Малоинвазивные методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. - Алматы, 1998. - С. 105.